جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : امل عبد الجواد محمود سيد

المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** المعادي **العنوان :** 24 ش محمد سليمان كوتسكا المعادى

رقم البطاقة : 27610051602344 **رقم التليفون :** 01227537006 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 18-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 05-10-1976 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي
التوقيع:(----------)

المقر بما فيه
التوقيع:(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: امل عبد الجواد محمود سيد
National ID: 27610051602344

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Further investigations and imaging**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : امل عبدالجواد محمود سيد
2-ID number: 27610051602344

Sex:

3- Medical number: 83060900
Female
Patient Age : 46 Y

MDT

Family history	-VE	Phone	01001852978
BMI	obese I	NRS Score	3
GROUP	A	marital status	
Menopausal status	PRE	Co morbidity	
Date of MDT	29-Sep-2022	☐ REASON OF MDT	PO

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :
BONE SCAN FREE 7/2022

BX:	IHC:	ER:	PR:	Her 2 Neu :	Ki67 :
IDC GIII 2/2022		8/8	8/8	-VE	60%

T	N	M
2	1	0

Sonomammography
2/2022 LEFT BREAST NORMAL STUDY BIRADS 1
RIGHT BREAST UOQ UNIFOCAL MALIGNANT MASS BIRADS 6

Recommendations:
Recived Neoadjavent ttt FECx 3 then TXT x 3
POST OPERATIVE DONE
WLE--> IDC GIII MARGINS FREE
NODES FREE NO SKIN INVOLVMENT -YPT1 YPN0

MDT OUTCOME & PLAN

FOR adjuvant ttt
post operative radiotherapy
hormonal ttt(AI+ Zoladex)
Prolia --- 6 months

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	د/ ايمان عبدالعزيز	RADIOLOGY	د/ هدايه نور
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Patient Name	: امل عبد الجواد محمود	Request No.	: 13001776
Patient No.	: 27610051602344	Request Date	: 31/01/2022
Path No.	: 267/2022	Verification Date	: 21/02/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 2 D	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:
Right breast mass

Nature of the specimen:
Tru-Cut biopsy

Gross Examination:
- Procedure: Tru-Cut biopsy (7 greyish white tissue cores, up to 1.5cm, totally submitted).
- Localization: 10 o'clock
- Immunohistochemical tecnique: Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR,HER2, ER clone (SP1), PR clone (1E2), HER-2 CLONE (4B5), &Ki67 (30-9)
Inform Her2 Dual ISH DNA Probe cocktail.

Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade 3 (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G (3+3+2)
- Angioinvasion: No
- Ductal carcinoma in situ: No
- Additional pathologic findings: No microcalcification
- ER: Strong nuclear reaction in about 90% of tumour cells. Positive, (Allred score 8/8)
- PR: Strong nuclear reaction in about 90% of tumour cells. Positive, (Allred score 8/8)
- Her-2: Strong incomplete membrane reaction in 10% of tumour cells. Equivoal, score 2+
- Ki67: 60%
- SISH: Not amplified (HER2 gene copy number is less than 4 and HER2/ CEP 17 ratio less than 2)

Verified by :
abdelrahman ibrahim

Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Nasr El Qadema- Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: امل عبد الجواد محمود	Request No.	: 13001776
Patient No.	: 27610051602344	Request Date	: 31/01/2022
Path No.	: 267/2022	Verification Date	: 21/02/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 2 D	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Diagnosis:
Right breast mass; Tru-Cut biopsy:
Invasive duct carcinoma grade 3
IHC:
ER: Positive, (Allred score 8/8)
PR: Positive, (Allred score 8/8)
Her-2: Equivoal, score 2+
Ki67: 60%
SISH: Not amplified (HER2 gene copy number is less than 4 and HER2/ CEP 17 ratio less than 2)

- Reference: ASCO-CAP HER2 Test Guideline Recommendations, 2018.IHC 0:as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within> = 10% of invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint /barely perceptible and within <10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: The revised definition of IHC 2+ (equivocal) is weak to moderate complete membrane staining observed in<10% of tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense in<10% of tumor cells

- ISH clinical groups:
The ratio is calculated and the results is interpreted as :
• Group I (Negative): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is less than 4 .
• Group II (Negative): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is > 4 and < 6. (Recounting give the same result).
• Group III (Positive): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 6 (Recounting give the same result).
• Group IV (Negative): HER2/CEP17 ratio is more than 2 & Average HER2 copy number/ cell

Verified by :
abdelrahman ibrahim

Room No. (4) - First Floor-Building No. 287- Nile Corniche - Nile El Qatrna- Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: امل عبد الجواد محمود	Request No.	: 13001776
Patient No.	: 27610051602344	Request Date	: 31/01/2022
Path No.	: 267/2022	Verification Date	: 21/02/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 2 D	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

is less than 4 . (after recounting in at least 20 cells = same results.
• Group V (Positive): HER2/CEP17 ratio is more than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 4.

Prof. Dr. Gamal Abd-El Aty
Prof. Dr. Amal Hareedy
Dr. Abdulrahman Ibrahim

Verified by :
abdelrahman ibrahim

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (257) – كورنيش النيل – بحر الكبير – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 257- Nile Corniche - Misr El Qadema- Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name : Amal Abdelgawad Mahmoud

Date : 6/3/2022

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

1. **Chest:**
   - Right breast mass is seen measuring about 2.3 x 2.9 cm with prominent right axillary lymph nodes the largest measuring about 1.6 x 0.9 cm.
   - No sizable pulmonary masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
   - No hilar or mediastinal lymph nodes.
   - No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
   - Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
   - Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
   - Normal appearance of the dorsal vertebrae.
2. **Abdomen and pelvis:**
   - The liver is average in size with homogenous CT texture. Single tiny hypodense focal lesion is seen within the right hepatic lobe segment VII measuring about 5 x 8 mm.
   - Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
   - No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
   - Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
   - Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
   - Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
   - Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
   - Bulky uterus is noted with IUD seen within.
   - Normal appearance of the other pelvic organs.
   - No abdominal or pelvic masses or collections.
   - No lytic or sclerotic bone lesions.

OPINION:

- ***Known case of breast cancer showing right breast mass and prominent right axillary lymph nodes.***
- ***Single right hepatic lobe tiny focal lesion likely of benign nature.***

Dr. Ahmed M. Rozeka, MSc

Dr.m.gomaa,md

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]